

Astenia funcional o síndrome de fatiga crónica

A. Kachaner, B. Ranque

Resumen: La astenia funcional o síndrome de fatiga crónica es una afección frecuente, invalidante y difícil de tratar. La primera etapa consiste en realizar un estudio minucioso que permita descartar causas somáticas que responden a un tratamiento médico específico. También hay que detectar posibles comorbilidades psiquiátricas o por adicciones y, en su caso, tratarlas. El tratamiento del síndrome de fatiga crónica está basado en técnicas de comunicación centradas en el paciente, en una limitación de su peregrinaje médico y en una terapéutica que gira en torno a la rehabilitación al esfuerzo, psicoterapia y, en ocasiones, prescripción medicamentosa prudente. El tratamiento de estos pacientes depende de la duración y a menudo permite una mejoría sustancial en caso de una buena alianza terapéutica y de objetivos accesibles compartidos con el paciente.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Astenia; Somatomorfo; Funcional; Fatiga crónica; Trastorno de síntomas somáticos; Síndrome de distrés corporal

Plan

■ Introducción	1
■ Descartar las principales causas de astenia evidentes, graves y/o de fácil curación, de origen somático	1
■ Detección de trastornos del sueño, depresión, trastorno asociado al consumo de sustancias	3
■ Diagnóstico positivo y tratamiento de un trastorno funcional somático	3
Definición, epidemiología, fisiopatología	3
Diagnóstico	4
Tratamiento de los pacientes con trastornos de síntomas somáticos	4
■ Conclusión	6

■ Introducción

El término «astenia» procede del griego: la «a» es privativa y *stenia* significa «fuerza». Se trata de un estado de fatiga importante que repercute en la vida diaria. Es un motivo frecuente de consulta en medicina general, difícil de manejar por la subjetividad del diagnóstico y por la diversidad de las posibles etiologías. La astenia funcional o síndrome de fatiga crónica define un estado de fatiga en el que no se detecta ninguna causa somática y que se acompaña de una repercusión funcional importante. Debe distinguirse de un estado de fatiga pasajero que es frecuente, benigno y reversible.

Muchas enfermedades somáticas pueden ser la causa de una astenia. Por lo tanto, la primera etapa consiste en realizar una búsqueda etiológica minuciosa. Si este estudio resulta negativo, es importante descartar una depresión, un trastorno asociado al consumo de alcohol o a un trastorno del sueño, que en muchos casos pueden manifestarse por una astenia. Por último, a falta de

otra causa y de acuerdo con determinados argumentos citados a continuación, se puede establecer el diagnóstico de trastorno funcional somático. El tratamiento de este tipo de trastorno se detalla en este artículo.

La orientación diagnóstica y el tratamiento se resumen en la Figura 1.

■ Descartar las principales causas de astenia evidentes, graves y/o de fácil curación, de origen somático

Con el fin de descartar las principales causas somáticas de astenia, se puede proceder como sigue:

- anamnesis minuciosa, centrada en particular en:
 - la antigüedad y modo de aparición de la fatiga, su periodicidad, los factores que la agravan o que la mejoran,
 - el tipo de vida (profesión y nivel de estrés profesional, entorno familiar y posibles conflictos familiares, actividad física, hábitos alimentarios, viajes, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas),
 - los antecedentes personales médicos y psiquiátricos, el tratamiento medicamentoso habitual,
 - los antecedentes familiares (en particular cánceres),
 - la búsqueda de síntomas asociados, especialmente sangrados, menstruación abundante, palpitaciones, fiebre, artralgias, erupción cutánea, síndrome de boca seca u ojo seco, mialgias, etc.;
- exploración física minuciosa y repetida en el curso de diferentes consultas, con búsqueda de una alteración objetiva del estado general (en particular pérdida de peso);
- análisis clínicos que permitan la detección de causas frecuentes y/o graves de astenia (cf recuadro);

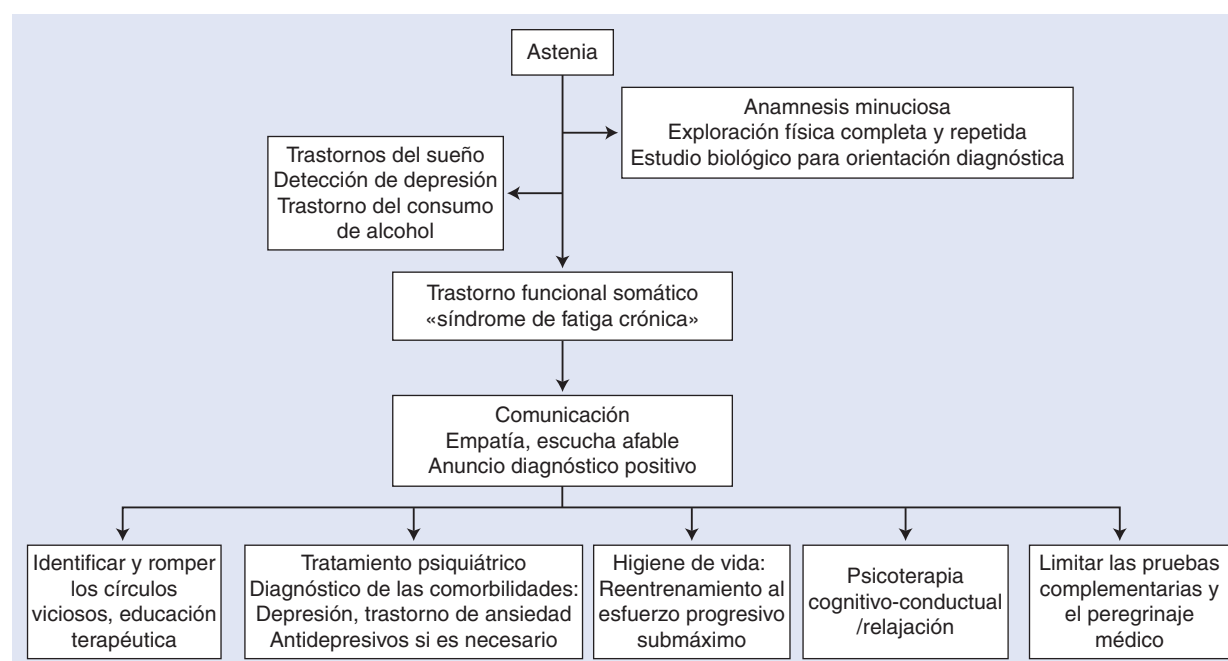


Figura 1. Árbol de decisiones. Orientación diagnóstica ante un cuadro de astenia y tratamiento de un trastorno somático funcional.

- detección sistemática de cánceres como está indicado según la edad y los antecedentes personales y familiares, especialmente tomografía computarizada (TC) torácica *low dose* en caso de tabaquismo, consulta ginecológica (y mamografía después de los 50 años) en la mujer, tacto rectal y determinación del antígeno prostático específico (PSA) en el varón mayor de 50 años;
- búsqueda de una apnea del sueño mediante poligrafía respiratoria ante apneas, ronquidos, obesidad, hipertensión arterial (HTA), cefaleas matinales y/o somnolencia diurna.

“ Punto importante

Estudio biológico para orientación diagnóstica (lista no exhaustiva, propuesta a título indicativo)

- Hemograma completo
- Ionograma sanguíneo, uremia, creatininemia
- Glucemia en ayunas
- Estudio hepático completo, creatina-fosfoquinasa (CPK)
- Ferritinemia
- Proteína C-reactiva (CRP), fibrinógeno
- Electroforesis de las proteínas séricas
- Calcemia, fosfatemia y magnesemia
- Serologías del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), serología del virus de Epstein-Barr (VEB) ante fatiga de menos de 6 meses
- Tirotropina (TSH), cortisolemia de 8 h o prueba de estimulación con cosintropina
- Anticuerpos inmunoglobulina A (IgA) antitransglutaminasas (en ausencia de déficit de IgA)

Si existe un antecedente personal de cáncer, de adelgazamiento o de síndrome inflamatorio, es muy recomendable realizar una TC toracoabdominopélvica con contraste, además de pruebas de detección de cáncer indicadas según la edad y el sexo del paciente (consulta ginecológica, PSA, endoscopias digestivas, etc.).

Si algunas de estas pruebas no son normales, conviene orientar la búsqueda etiológica. En particular, en caso de síndrome inflamatorio biológico, la conducta práctica es la de un síndrome

inflamatorio crónico o de una fiebre prolongada no justificada (v. artículo correspondiente).

La exploración física y estas pruebas complementarias permiten descartar las causas más frecuentes (cf recuadro).

“ Punto fundamental

Principales causas somáticas de fatiga crónica (lista no exhaustiva)

- Cáncer sólido o hemopatía
- Embarazo
- Infección crónica: hepatitis, mononucleosis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, etc.
- Anemia o carencia de hierro
- Enfermedad endocrina: diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, etc.
- Enfermedad metabólica: insuficiencia renal crónica, malnutrición, hiponatremia, hipopotasemia, hipercalcemia, etc.
- Enfermedad digestiva: enfermedad celíaca, enfermedades intestinales inflamatorias crónicas (EII), etc.
- Enfermedad del hígado: hepatitis crónica, hemocromatosis, cirrosis, etc.
- Enfermedad autoinmunitaria multisistémica: lupus, esclerodermia, enfermedad de Sjögren, sarcoidosis, vasculitis, etc.
- Reumatismo inflamatorio: artritis reumatoide, espondiloartritis anquilosante, etc.
- Enfermedad neurológica: enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, miastenia, síndrome de las piernas inquietas, etc.
- Enfermedad respiratoria: síndrome de apnea del sueño, bronquitis crónica, etc.
- Enfermedad cardiovascular: insuficiencia cardíaca, etc.
- Iatrogenia: quimioterapia y también betabloqueantes, antidepresivos, sedantes, psicótrópos, analgésicos, diuréticos, antihistamínicos, etc.

Algunos diagnósticos son más difíciles y, en caso de duda, justifican la consulta con un especialista:

- en caso de déficit motor o de CPK elevadas, buscar una miositis o una miopatía: electromiograma (EMG), resonancia magnética (RM) muscular ± biopsia muscular;
- en caso de síntomas neurológicos sensitivos o motores transitorios, buscar una esclerosis múltiple: RM cerebral con inyección de gadolinio;
- en caso de erupción cutánea, prurito, eritema, trastornos digestivos, pensar en una mastocitosis y medir la triptasa.

Sin embargo, las pistas etiológicas escasas y/o improbables sugeridas por el propio paciente no deben conducir a pruebas más complicadas si no existe una presunción o sospecha clínica.

Algunas pruebas son inútiles e incluso fuente de complicaciones, como por ejemplo:

- la serología de la enfermedad de Lyme si no hay una mordedura de garrapata o un signo evocador de enfermedad de Lyme terciaria (dolores de tipo neuropáticos de territorio radicular, en particular), porque hay muchos casos de borreliosis curadas, que no justifican ningún tratamiento;
- la búsqueda de autoanticuerpos, especialmente de ANA en ausencia de signos clínicos de conectivitis (síndrome seco ocular, erupción cutánea, alopecia o esclerodactilia, síndrome de Raynaud, artralgias, mialgias, citopenia, elevación de las creatina-cinasas, etc.), ya que se dan muchas positividads sin traducción clínica, que no justifican ningún tratamiento;
- la búsqueda de una intoxicación por metales pesados si no hay una exposición evidente;
- la búsqueda de una «intolerancia» a grandes paneles de alimentos propuesta por algunos laboratorios (serologías en busca de IgG antialimentos, cuyo valor científico no está reconocido), diferente de la búsqueda de alergias mediadas por las IgE o de la enfermedad celíaca (IgA antitransglutaminasas).

Por lo tanto, hay que saber limitar el número de pruebas cuando la fatiga es un síntoma aislado, la presentación clínica no es alarmante (en particular si no hay adelgazamiento) y la evaluación para la orientación diagnóstica es normal, sin síndrome inflamatorio.

■ **Detección de trastornos del sueño, depresión, trastorno asociado al consumo de sustancias**

Los trastornos del sueño son frecuentes y deben detectarse mediante una anamnesis minuciosa. Pueden formar parte de múltiples afecciones.

- Es necesario descartar especialmente las siguientes afecciones:
- síndrome de apnea del sueño: preguntar a su pareja sobre la presencia de apneas o de ronquidos, recurrir al cuestionario de Epworth, realizar una poligrafía respiratoria en caso de duda;
 - síndrome de las piernas inquietas: preguntar al paciente e incluso realizar una polisomnografía en caso de duda;
 - patología urinaria o prostática en pacientes mayores;
 - iatrogenia, como las prescripciones de diuréticos o de corticoides por la noche.

Por otra parte, no hay que olvidar un posible trastorno de ansiedad o un episodio depresivo determinado, ya que estas afecciones son muy frecuentes en la población general y accesibles a tratamientos eficaces. Para la detección de una depresión se puede recurrir a cuestionarios validados como MADRS, pero su uso es cronófono. La presencia de tristeza o la pérdida de placer en las actividades cotidianas pueden orientar hacia un episodio depresivo definido. Los trastornos del sueño y del apetito suelen estar asociados. En caso de duda, puede ser necesaria una consulta de psiquiatría.

También habrá que buscar un consumo de sustancias tóxicas. En particular, el consumo abusivo de alcohol es una causa clásica de astenia y depresión. Es conveniente repetir la anamnesis, porque el paciente puede negar parte del trastorno. También hay que descartar un consumo de cannabis o de otras sustancias psicoactivas.

Cuadro 1.
Criterios diagnósticos para el trastorno funcional somático (o trastorno de síntomas somáticos).

Criterio para el trastorno de síntomas somáticos (somatic symptom disorder), DSM-5
A. Uno o varios síntomas somáticos invalidantes o asociados a una repercusión importante en la vida diaria
B. Preocupaciones excesivas, cortejo afectivo importante, conductas que parecen desproporcionadas en relación con los síntomas, como: - inquietud persistente sobre la gravedad de los síntomas - nivel de ansiedad elevado en relación con los síntomas y el estado de salud en general - tiempo y energía consagrados a los síntomas considerados desproporcionados
C. Evolución global clásicamente superior a 6 meses (cada síntoma puede ser fluctuante)

El conjunto de todas estas causas mencionadas anteriormente pueden coexistir en un mismo paciente, y la presencia de una de ellas no descarta la búsqueda de las otras.

■ **Diagnóstico positivo y tratamiento de un trastorno funcional somático**

Definición, epidemiología, fisiopatología

Este trastorno recibe muchos nombres: trastorno somatomorfo, trastorno funcional, trastorno funcional somático, trastorno de síntomas somáticos, síntoma médicamente inexplicado, síndrome de hipersensibilización central, trastorno psicógeno o psicósomático, o síndrome de distrés corporal.

Es una afección extremadamente frecuente en la población general; representa alrededor del 10% de todos los trastornos funcionales y del orden del 6% para el síndrome de fatiga crónica, que es un trastorno funcional cuyo síntoma principal es la astenia [1]. En la medicina privada u hospitalaria, estas afecciones son todavía más frecuentes. Más de un 40% de los pacientes que acude a una consulta de medicina general presenta al menos una queja médicamente inexplicada [2]; además, la prevalencia de las consultas por síntomas médicamente inexplicados en el medio hospitalario puede rondar el 30% en distintas especialidades [3].

Desde 2013, el *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (DSM)-5 ha adoptado la definición de «trastorno de síntomas somáticos» (somatic symptoms disorders) [4] (Cuadro 1).

- Para cumplir estos criterios, se necesitan:
- un síntoma que altere la vida cotidiana;
 - pensamientos o conductas considerados excesivos en relación con este síntoma;
 - una evolución crónica (típicamente, más de 6 meses).

Entre estos trastornos, existen numerosas entidades según los síntomas presentes que predominen: síndrome del intestino irritable, fibromialgia (cuadro doloroso musculoesquelético difuso), síndrome de fatiga crónica, etc. La presencia de síntomas que afecten a varios órganos es un factor de riesgo de cronicidad en esta afección [5]. Probablemente, estas entidades diferentes sean distintas presentaciones de una misma afección y, entre ellas, presentarían un continuum fisiopatológico importante. Además, a menudo están asociadas entre ellas.

Estos trastornos pueden aparecer de forma aislada o sumarse a la evolución de una enfermedad crónica. Así por ejemplo, es frecuente observar que pacientes con lupus desarrollen una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica asociados. A veces, la enfermedad inicial crea un «anclaje» para el trastorno funcional. Esto ocurre por ejemplo con los dolores torácicos sine materia que aparecen después de varios episodios de pericarditis. Por lo tanto, la presencia de una afección subyacente no debe hacer descartar un trastorno funcional somático, sino que, más bien al contrario, es bastante frecuente.

Sigue sin comprenderse bien la fisiopatología de estos trastornos. Es probable que exista un descenso del umbral de detección del dolor y una modulación de la señal dolorosa y desagradable. Estudios realizados con RM funcional han mostrado esquemas de activación neuronal propias de la fibromialgia que no se observan en personas sanas [6]. En estos pacientes [7], los sistemas de control ascendentes y descendentes del dolor parecen ser deficientes. Varios estudios, aunque con muestras pequeñas, sugieren que pueda tratarse de una disfunción del sistema inmunitario, con respuestas citocínicas particulares en las personas aquejadas de un síndrome de fatiga crónica [8]. Otros estudios [9] también sugieren posibles predisposiciones genéticas para este tipo de trastorno, pero los conocimientos validados sobre esta afección son realmente escasos. Este desconocimiento sobre su fisiopatología dificulta en gran medida el tratamiento, porque hace que la enfermedad sea difícil de identificar y crea numerosas controversias [10]. Algunos médicos y asociaciones de pacientes han planteado en repetidas ocasiones determinadas hipótesis, en particular postinfecciosas (el ejemplo más emblemático es la enfermedad de Lyme crónica) o ambientales (exposición a ondas magnéticas), que no han sido aprobadas por la comunidad científica ante la falta de datos fehacientes. En cambio, sí hay unanimidad en admitir que existe un componente psicológico importante en su desarrollo y, sobre todo, en la persistencia de los síntomas.

Diagnóstico

El diagnóstico de «trastorno funcional somático» no es un diagnóstico de exclusión. Incluye factores de riesgo y argumentos clínicos evocadores. Los elementos citados a continuación hablan en favor del diagnóstico, pero ninguno de ellos es necesario ni suficiente; el diagnóstico se basa en un abanico de argumentos. La enfermedad es probable si se observan algunos de los siguientes elementos:

- presentación «tortuosa» de su historia por parte del paciente, difícil de reconstituir: signos exclusivamente funcionales, de descripción extraña, no sistematizados, de localización e intensidad fluctuantes;
- peregrinaje médico importante, multiplicidad de pruebas complementarias;
- relación compleja con los médicos, a veces incluso conflictiva;
- atención patológica al mínimo síntoma, ansiedad exagerada por la salud.

Repercusión exagerada en la vida privada y profesional, que contrasta con el buen estado general del paciente.

Trastornos de la personalidad y rasgos de carácter asociados a los trastornos funcionales somáticos [11]:

- alto nivel de autoexigencia;
- baja autoestima;
- personalidad estricta, obsesiva;
- personalidad ansiosa;
- alexitimia (dificultad para identificar sus emociones).

Otros factores de riesgo:

- vivencia traumática, a veces ocultada: accidente grave, maltrato (físico o psíquico), duelo, abandono, abusos sexuales, etc.;
- sexo femenino;
- antecedente de otros trastornos funcionales somáticos (colon irritable, cefaleas de tensión) [12];
- antecedentes psiquiátricos (a menudo omitidos voluntariamente o no por el paciente al comienzo de la visita) [13].

Tratamiento de los pacientes con trastornos de síntomas somáticos [14]

Comunicación y diagnóstico positivo [15]

La comunicación aquí debe tener una importancia muy particular. Estos pacientes a menudo se sienten maltratados por el cuerpo médico, que a veces dice «Usted no tiene nada» o «Está en su cabeza» o incluso «¡Usted me hace perder el tiempo!», pese al gran sufrimiento mostrado por el paciente. Una escucha empática y afable es fundamental en el proceso terapéutico. El médico, para establecer un clima de confianza y ser escuchado, primero

“Punto importante

Ejemplos de situaciones referidas por los pacientes

- «No me encuentran nada, me dicen que no tengo nada y sin embargo he perdido todo en mi vida por esta enfermedad. Estoy en una situación de discapacidad»
- «Me he sentido realmente maltratado por el cuerpo médico»
- «Debo permanecer acostado la mitad del día, es como si tuviera media vida»
- «Esta situación es socialmente insoportable, los que se rompen una pierna pueden decir “me he roto la pierna” y seguir viviendo. Yo no puedo decir nada»
- «Es mi única preocupación desde hace 10 años»
- «Ya ni siquiera puedo ocuparme de mis hijos»

debe reconocer el sufrimiento del paciente y la repercusión de esta afección en su vida. Como ejemplo puede decirle: «veo que usted sufre mucho» u «observo que lo que le pasa tiene graves consecuencias en su vida». Debe crear una alianza con el paciente que haga que este último interprete sus síntomas de manera diferente, participando plenamente en su tratamiento.

El diagnóstico debe ser anunciado de manera positiva. Es conveniente darle un nombre al trastorno e incluso enumerar los sinónimos (trastorno funcional, trastorno somatomorfo, síndrome de fatiga crónica, etc.) que el paciente podrá oír si consulta a otro médico. Se puede insistir en que la enfermedad es extremadamente frecuente. Además, es importante proporcionarle una explicación, aunque sea esquemática, como que consiste en el desajuste del «termostato» cerebral de la fatiga o en un cerebro «parasitado» por emociones negativas inconscientes, sin que los propios órganos estén lesionados. El médico puede reconocer que los mecanismos de estos trastornos no se conocen bien en la actualidad, pero que existen pruebas indiscutibles sobre la estrecha conexión entre la mente y el cuerpo.

Lo mejor es partir de las ideas del paciente para llegar a una explicación que le resulte comprensible e inteligible. La explicación debe formularse con convicción, teniendo en cuenta el nivel intelectual y el sistema de valores del paciente. A continuación, se proponen algunos ejemplos de posibles explicaciones que se pueden dar sobre el origen de los trastornos somatomorfos:

- en la vida corriente, existen numerosos ejemplos de síntomas físicos asociados al estrés, a las emociones. A algunas personas les duele la tripa al pasar un examen, otros transpiran cuando están nerviosos y a otros se les acelera la frecuencia cardíaca cuando hablan en público. Las lágrimas son un síntoma físico que viene de la tristeza. Todo esto demuestra que existe una relación directa entre el cuerpo y la mente;
- se habrá dado cuenta que el dolor o la fatiga pueden desaparecer cuando nuestros pensamientos están acaparados por una actividad apasionante (lectura, cine, etc.);
- en cambio, cuando el cerebro está sometido durante largo tiempo a un estrés importante, amplifica e incluso puede provocar síntomas como el dolor o la fatiga;
- aunque tenga la impresión de estar extremadamente cansado, usted habrá observado que si se empeña en hacer un esfuerzo físico, su cuerpo es capaz de hacerlo: se trata de una sensación de fatiga psicológica que es diferente de la fatiga física pasajera que sentirá si prolonga demasiado el esfuerzo;
- el cerebro interpreta todas las señales externas (sensoriales) que le llegan, en función de su estado emocional y de sus experiencias pasadas. Un mismo sonido o una misma imagen no provocan el mismo sentimiento en dos personas distintas. Su cerebro amplifica o incluso produce una señal de fatiga porque está alterado por fuertes emociones o recuerdos traumáticos;
- existe una hipersensibilización de su sistema nervioso central asociada a un desajuste de las informaciones sensoriales que se envían al cerebro: el umbral al que se percibe el dolor y las sensaciones desagradables es más bajo de lo normal.

Cuadro 2.
Puntos esenciales en el tratamiento de un paciente aquejado de un trastorno funcional somático.

Promover	Evitar
Escucha activa y preguntas abiertas con reformulación de las respuestas	Quitarle la palabra, hablar sin escuchar al paciente
Mostrar empatía con regularidad	Minimizar los trastornos descritos
Dar un diagnóstico positivo y precoz de trastorno funcional	Decir: «Usted no tiene nada grave», «Está todo en su cabeza», «Tiene que moverse más», «No puedo hacer nada por usted», etc.
Proponer un seguimiento simultáneo con un psiquiatra o un psicólogo	Rechazar cualquier explicación propuesta por el paciente
Comunicarse abiertamente con los otros médicos, evitando las jergas	Prescribir pruebas complementarias ya realizadas o sin una justificación médica
Recomendar vivamente la actividad física, aunque sea moderada	Derivar al paciente a especialistas en enfermedades raras a instancia suya (salvo si existe una sospecha médica justificada)
Fomentar las actividades culturales o manuales preferidas del paciente	
Establecer un contrato terapéutico con objetivos razonables, elegidos con el paciente	

El diagnóstico debe plantearse lo antes posible durante el proceso terapéutico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes pueden negar en un primer momento cualquier componente psíquico: «¡Una cosa es segura, doctor, y es que esto no sucede en mi cabeza!», «Yo he sido siempre un luchador, no soy de las que se escucha». Es inútil e incluso contraproducente oponerse a esta reacción de defensa natural en nuestra civilización, en la que los trastornos psíquicos están muy estigmatizados. Habrá que abordar de nuevo el problema una vez establecida la relación de confianza. El médico también deberá evaluar la «cibercondría» del paciente, es decir, su tendencia a realizar múltiples búsquedas en internet en relación con sus síntomas ^[16]. La «cibercondría» aumenta en gran medida la ansiedad asociada a la salud, ya que las informaciones halladas pueden ser contradictorias o falsamente alarmantes. Se debe recomendar al paciente que limite sus consultas en internet y que plantee las preguntas sobre sus síntomas a su médico.

Detectar los círculos viciosos

Los círculos viciosos se refieren a las actitudes contraproducentes del paciente que autoagravan su trastorno. Así, por ejemplo, en un síndrome de fatiga crónica, si un día el paciente se siente menos cansado, tratará de hacer todas las labores del hogar retrasadas, y al hacerlas, se sentirá aún más cansado en los días siguientes. Esto le llevará a deducir que no aguanta la actividad física, dejará cualquier actividad y ello le provocará un desacondicionamiento muscular, esquelético y cardíaco que a su vez le causará una fatigabilidad excesiva ante la menor actividad. En este caso, para romper el círculo vicioso, el paciente deberá respetar un nivel de actividad física diaria mínima y máxima, que no provoque el agravamiento de sus trastornos.

Peregrinaje médico

Se recomienda frenar el peregrinaje médico, para lo cual es conveniente que sólo intervenga un médico de referencia por especialidad. También se recomienda programar consultas regulares, fuera de los paroxismos sintomáticos, con el médico de referencia. El médico de referencia del paciente (internista o especialista) será el encargado de establecer la relación con los otros médicos del paciente. Es fundamental que los médicos de referencia tengan un discurso coherente y que el que mejor conozca este tipo de trastornos establezca «una conducta práctica» por los otros médicos (no prescribir nuevas pruebas complementarias, no remitir al paciente a un médico nuevo, no volver a cuestionar el diagnóstico de «trastorno funcional somático» si no hay un signo clínico objetivo o una anomalía biológica significativa, etc.). La repetición de pruebas complementarias y la derivación a nuevos especialistas deben evitarse a toda costa. La realización de pruebas complementarias provoca una focalización ansiosa del paciente en su síntoma, una espera del resultado y la impresión de que sólo puede vivir con tranquilidad haciéndose nuevas pruebas complementarias. Además, su repetición a veces conduce a falsos positivos o a la detección de incidentalomas que pueden inquietar al paciente y hacerle solicitar nuevas pruebas. Por lo tanto, son iatrogénicas. En cambio, se pueden prescribir algunas pruebas complementarias con una cierta regularidad, de manera justificada: por ejemplo, se puede repetir el análisis ini-

cial (de orientación diagnóstica) una vez al año (salvo las pruebas inmunológicas, que es inútil repetir si no hay nuevos signos). También hay que evitar recurrir a especialistas en enfermedades raras cuando el diagnóstico de trastorno funcional es evidente, porque puede resultar nefasto. Con mucha frecuencia, los médicos mandan al paciente a numerosos especialistas o prescriben pruebas complementarias cuando no están satisfechos de su propio tratamiento, cuando tienen un sentimiento de fracaso y necesitan ayuda para manejar esta compleja situación. Se trata de una reacción natural pero que hay que evitar siempre que sea posible, porque favorece la persistencia de los trastornos. Los pacientes pueden quejarse de no haber sido correctamente tratados por un médico anterior, incluso pueden estar litigando con sus médicos de antes, por haberse sentido mal tratados. Con mucha frecuencia, se trata de torpezas en la comunicación (Cuadro 2) o de una actitud de rechazo más o menos explícita por parte de los médicos, que se sentían impotentes frente a este cuadro. Estas actitudes de los médicos favorecen el peregrinaje del paciente, y las malas experiencias pasadas provocan una pérdida de confianza con los médicos que complica en gran medida la relación terapéutica. El restablecimiento de una relación de confianza es el primer objetivo que hay que cumplir.

Actitud terapéutica

En definitiva, lo más importante es la instauración de una relación de confianza entre el médico y su paciente. Para ello, los médicos deben mostrar una actitud de gran empatía. El paciente necesita saber en todo momento que el médico considera sus síntomas reales y muy invalidantes. Debe comprender que el objetivo principal de su médico no es tanto establecer un diagnóstico positivo como ayudarle a recuperar su vida normal. Es conveniente que el paciente vuelva a expresar lo que ha comprendido y lo que piensa, para poder conocer su opinión, sus prioridades y conocer sus inquietudes. El paciente debe dejar de buscar un diagnóstico de enfermedad rara, pero sabiendo que el aspecto somático no será ocultado si aparecen nuevos elementos semiológicos. Después, se definirán conjuntamente objetivos terapéuticos, de acuerdo con los propios recursos del paciente. Deben ser razonables (no prometer una curación en 3 meses). Habrá que apoyar al paciente para que él mismo elija la pista o pistas terapéuticas complementarias que más le convengan. Por lo tanto, la consulta se asemeja a una entrevista motivacional, para la que se necesita una buena capacidad de escucha, una formulación de preguntas abiertas y una reformulación de las respuestas. La readaptación al esfuerzo es fundamental. El paciente debe retomar una actividad física suave pero regular. Como primera opción se pueden proponer actividades como taichí, qigong, yoga, marcha nórdica o natación. El taichí ha sido evaluado en un ensayo aleatorizado de alto nivel y ha sido considerado eficaz en la fibromialgia ^[17]. Según un metaanálisis Cochrane ^[18], el ejercicio físico proporciona una mejoría de los síntomas y de la calidad de vida. En caso de reticencia por parte del paciente, se pueden prescribir unas sesiones de kinesiterapia motora para retomar una actividad física supervisada. También está indicada una consulta de psiquiatría con el fin de detectar trastornos psiquiátricos definidos, frecuentemente asociados a trastornos funcionales somáticos, como una depresión o un trastorno de ansiedad. El hecho de continuar con un

tratamiento psiquiátrico dependerá de esta primera evaluación. A menudo, los pacientes aceptan mal este seguimiento psiquiátrico porque temen una estigmatización tanto por parte del médico como de su entorno. Por lo tanto, esta cuestión se propondrá con tacto, asegurándole a la vez el mantenimiento de un seguimiento somático simultáneo. Es muy conveniente que el médico se comuniquen con el psiquiatra para informarle de la situación e incluso que tengan una consulta conjunta si ello es posible.

La psicoterapia es a menudo muy útil. Numerosos estudios muestran el beneficio de las TCC (terapias cognitivo-conductuales) y, en particular, de la reestructuración cognitiva y de la terapia basada en la conciencia plena^[19]. Así pues, estos tipos de psicoterapia son muy recomendables. Por ejemplo en Francia, los profesionales formados en estas técnicas figuran en la página de internet <https://www.aftcc.org/>.

El tratamiento medicamentoso es delicado y en ningún caso sistemático. Si hay dolores, la prescripción de analgésicos debe tener en cuenta el riesgo de dependencia y que las intolerancias medicamentosas suelen ser múltiples. La prescripción de antidepresivos no se realiza cuando no existe un episodio depresivo definido. La duloxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) que muestra una eficacia modesta pero real frente a la fibromialgia y a los dolores crónicos en general^[20], pero poca sobre la fatiga.

Muchos pacientes pueden recurrir a medicinas alternativas: acupuntura, fitoterapia, hipnosis, etc. Estos métodos pueden y deben recomendarse si les proporcionan bienestar (y no les arruinan). También es necesario analizar la composición de los complementos alimentarios consumidos por el paciente para descartar interacciones medicamentosas con los tratamientos prescritos y evitar restricciones alimentarias múltiples, salvo en caso de alergias demostradas.

Factores pronósticos

Los siguientes factores están asociados a la gravedad de los trastornos^[21]:

- una mala condición física;
- el sexo femenino;
- la precariedad;
- los abusos físicos durante la infancia;
- síntomas intensos y múltiples desde el principio.

Los factores de mal pronóstico son señales de alarma que requieren la instauración de un máximo de medios: seguimiento psiquiátrico y psicoterapéutico, consultas frecuentes, tratamientos medicamentosos y actuación sobre el entorno del paciente.

■ Conclusión

Los trastornos funcionales somáticos son enfermedades frecuentes y potencialmente graves porque pueden ser causa de un

deterioro importante de la calidad de vida. El síndrome de fatiga crónica es uno de los trastornos funcionales somáticos más frecuentes. Después de haber descartado las otras grandes causas de astenia y de haber identificado los elementos semiológicos característicos de un trastorno funcional, una actitud terapéutica basada en la empatía, la formulación de un diagnóstico positivo, el dismantelamiento de los círculos viciosos, un seguimiento paralelo psiquiátrico o psicológico, la valorización de la higiene de vida y determinadas terapéuticas medicamentosas y no medicamentosas puede proporcionar una mejoría sustancial en los pacientes. La cooperación en la relación médico-paciente es la clave para un tratamiento eficaz en este tipo de trastorno.

■ Bibliografía

- [1] Petersen MW, Schröder A, Jørgensen T, Ørnboel E, Meinertz Dantoft T, Eliassen M, et al. Irritable bowel, chronic widespread pain, chronic fatigue and related syndromes are prevalent and highly overlapping in the general population: DanFunD. *Sci Rep* 2020;**10**:3273.
- [2] Haller H, Cramer H, Lauche R, Dobos G. Somatoform disorders and medically unexplained symptoms in primary care. *Deutsches Arzteblatt Online* [Internet]. 17 avr 2015 [cité 17 avr. 2020]. Disponible sur : <https://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2015.0279>.
- [3] Reid S. Medically unexplained symptoms in frequent attenders of secondary health care: retrospective cohort study. *Br Med J* 2001;**322**:767.
- [4] Dimsdale JE, Creed F, Escobar J, Sharpe M, Wulsin L, Barsky A, et al. Somatic symptom disorder: an important change in DSM. *J Psychosom Res* 2013;**75**:223–8.
- [5] Budtz-Lilly A, Vestergaard M, Fink P, Carlsen AH, Rosendal M. The prognosis of bodily distress syndrome: a cohort study in primary care. *Gen Hosp Psychiatry* 2015;**37**:560–6.
- [6] López-Solà M, Woo C-W, Pujol J, Deus J, Harrison BJ, Monfort J, et al. Towards a neurophysiological signature for fibromyalgia. *Pain* 2017;**158**:34–47.
- [7] Julien N, Goffaux P, Arsénault P, Marchand S. Widespread pain in fibromyalgia is related to a deficit of endogenous pain inhibition. *Pain* 2005;**114**:295–302.
- [8] Montoya JG, Holmes TH, Anderson JN, Maecker HT, Rosenberg-Hasson Y, Valencia JJ, et al. Cytokine signature associated with disease severity in chronic fatigue syndrome patients. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2017;**114**:E7150–8.
- [9] Wang T, Yin J, Miller AH, Xiao C. A systematic review of the association between fatigue and genetic polymorphisms. *Brain Behav Immun* 2017;**62**:230–44.
- [10] Maxmen A. A reboot for chronic fatigue syndrome research. *Nature* 2018;**553**:14–7.
- [11] Yeshua M, Zohar AH, Berkovich L. “Silence! The body is speaking” – a correlational study of personality, perfectionism, and self-compassion as risk and protective factors for psychosomatic symptoms distress. *Psychol Health Med* 2019;**24**:229–40.
- [12] Hudson JI, Arnold LM, Keck PE, Auchenbach MB, Pope HG. Family study of fibromyalgia and affective spectrum disorder. *Biol Psychiatry* 2004;**56**:884–91.
- [13] Arnold LM, Hudson JI, Keck PE, Auchenbach MB, Javaras KN, Hess EV. Comorbidity of fibromyalgia and psychiatric disorders. *J Clin Psychiatry* 2006;**67**:1219–25.
- [14] Roenneberg C, Sattel H, Schaefer R, Henningsen P, Hausteiner-Wiehe C. Functional somatic symptoms. *Deutsches Arzteblatt Online* [Internet]. 19 août 2019 [cité 2 mars 2020]. Disponible sur : <https://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2019.0553>.
- [15] Brownell AK, Atkins C, Whiteley A, Woollard RF, Kornelsen J. Clinical practitioners’ views on the management of patients with medically unexplained physical symptoms (MUPS): a qualitative study. *BMJ Open* 2016;**6**:e012379.
- [16] Starcevic V. Cyberchondria: challenges of problematic online searches for health-related information. *Psychother Psychosom* 2017;**86**:129–33.
- [17] Wang C, Schmid CH, Rones R, Kalish R, Vinh J, Goldenberg DL, et al. A randomized trial of Tai Chi for fibromyalgia. *N Engl J Med* 2010;**363**:743–54.
- [18] Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. *Cochrane Common Mental Disorders. Cochrane Database Syst Rev* 2017;(3):CD003200.
- [19] van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, Kleinstäuber M, Leone SS, Terluin B, et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;(11):CD011142.

“Puntos esenciales

Consejos de higiene de vida para prevenir la fatiga en la población general

- Reducir el ritmo de vida diario mediante pausas regulares, incluso en el puesto de trabajo
- Reservar un tiempo para uno mismo y para relajarse
- Practicar una actividad física regular (varias veces por semana), mantenida (marcha nórdica, carrera, natación, bicicleta, baile, yoga, etc.) pero sin excesos y con tiempos de recuperación suficientes
- Seguir una alimentación equilibrada y variada
- Evitar el alcohol, las comidas copiosas y estimulantes como el tabaco y la cafeína
- Respetar horarios regulares para acostarse y levantarse
- Buscar una actividad relajante a la hora de acostarse como la lectura, los estiramientos, la meditación, etc.

[20] Lunn MP, Hughes RA, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;(4):CD007115.

[21] Lamahewa K, Buszewicz M, Walters K, Marston L, Nazareth I. Persistent unexplained physical symptoms: a prospective longitudinal cohort study in UK primary care. *Br J Gen Pract* 2019;**69**:e246–53.

A. Kachaner, Interne en médecine interne (alexandra.kachaner@aphp.fr).
Université de Paris, 85, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, France.

B. Ranque, Professeur des Universités, praticien hospitalier.

Service de médecine interne, Hôpital européen Georges-Pompidou, Assistance publique des Hôpitaux de Paris, Centre Université de Paris, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Kachaner A, Ranque B. Astenia funcional o síndrome de fatiga crónica. EMC - Tratado de medicina 2021;25(2):1-7 [Artículo E – 1-0275].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones
complementarias



Videos/
Animaciones



Aspectos
legales



Información
al paciente



Informaciones
complementarias



Auto-
evaluación



Caso
clínico